

26833661839

NS 22231567554 / 666

Michelle Frigi Vantini Siqueira

IDADE: 45 PESO: 90 ALTURA: 161 PROFISSÃO: Professora
 SINTOMAS: cansaço - sonolência excessiva.
 QUEIXAS: memória ruim. / Zumbido / acorda em apneia
 MEDICAMENTOS: Puran 125 / clondrato Velaferina / Hidro
 clorotiazida 25mg.
 MÉDICO: Dr. Ricardo
 EXERCÍCIO FÍSICO: não faz exerc.
 HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: - JANTAR: 19:30
 HORA QUE DORME: 00:30 HORA QUE ACORDA: 6:10.
 COCHILO () SIM () NÃO DORME ACOMPANHADO () SIM () NÃO () EVENTUAL
 BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA () NÃO
 FUMO () SIM () MAÇO/DIA () NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: -
 TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO: Ox
 CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: gôbora CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:
 OVERLAP: não MALLAMPATI: II IAH: 39.2 SPO2: 93% med.
 PATOLOGIAS ASSOCIADAS: 80% min.
 CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA Rinite
 HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: Tireoidectomia
 COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA
 (S) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS

16/10 Há 11 anos começou a ganhar peso
 há histórico de formigalo nos mãos e 'big
 q's

13/11 P = 11.0

B

83

m. de uso: 7h 11'

IAH = 0.6 e/h

Bem adaptada.

fua

18/04

P = 9 cm H₂O

24

IAH = 0.4 e/h

m. de uso: 7h 29m

Bem adaptada

15/queixas
 natacha

DR. ALBERTO REMESAR

PSIQUIATRIA

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOME: Michelle Frigi Vantine Siqueira

EXAME nº: 5443

SOLICITADO POR: Dra. Aline Aparecida Barreto Silva Lederer

DATA: 24/07/2023

IDADE: 45 anos

Comentários:

Exame iniciado às 21h45min e concluído às 06h03min. A latência para o sono foi de 15 minutos e a latência para o estágio REM, de 246 minutos. O tempo total de sono foi de 469 minutos (07h49min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 94%. A distribuição do sono mostrou 9,6% de estágio 1, 57,9% de estágio 2, 14,9% de estágio 3 e 17,6% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 14,5 minutos em vigília, ocorreram 90 microdespertares (índice: 11,5/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 39,2/hora, sendo 1 apneia/hora e 38,1 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 48,1/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 95%, sendo a média de 93% e a mínima de 80%.

(*) TTS ⇨ Tempo Total de Sono TTR ⇨ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (39,2/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (48,1/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina e ritmo cardíaco sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 69; máxima: 98 bpm.

O ronco foi contínuo e variou de baixo a alto.
Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

A paciente adormeceu no tempo esperado (latência para o sono: 15 min; normal até 30 min). A latência para o sono REM estava alongada (246 min; normal: 70 a 120 min). A eficiência do sono (94%; normal: 85% ou acima) e o índice de microdespertares (11,5/hora; normal até 15/hora) mantiveram-se nos limites da normalidade – observei o padrão alternante cíclico (PAC) no estágio 2. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 2 (57,9%; normal: 45-55%) e 3 (14,9%; normal: 10-12%), e a redução do estágio REM (17,6%; normal: 20%). A porcentagem do estágio 1 (9,6%; normal: 8-10%) permaneceu nos limites da normalidade.

Sem movimentos periódicos de membros.

Escala de Sonolência de Epworth: 6 (normal até 9; máxima: 24).

Dr. Alberto Remesar Lopez
Médico
CRM-SP 69.730

Dr. Alberto Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730